RAPPORT D'AUDIT — SEPTEMBRE 2026

Audit Marketing & Référencement (SEO)

Analyse technique, sémantique et marketing du site **addict-helper.ronanbch.com**, avec plan d'action 30 / 60 / 90 jours.

Site audité : addict-helper.ronanbch.com

Date de l'audit : 16 septembre 2026

Document 2 sur 2 — voir aussi l'audit Graphique & UX

Sommaire

1. Résumé exécutif 3
2. SEO technique 4
3. Contenu et sémantique 5
4. Autorité et netlinking 6
5. Marketing et conversion 6
6. Conformité et confiance 8
7. Plan d'action 30 / 60 / 90 jours 8
8. Indicateurs à suivre 9

1. Résumé exécutif

Le site Addict Helper est techniquement propre (HTTPS, HSTS, site rapide sur Vercel, robots.txt présent), mais il est **quasi invisible pour les moteurs de recherche** : déclaration de langue erronée, absence de sitemap, absence de données structurées, balises sociales incomplètes, contenu unique et très mince, et un nom de domaine de sous-domaine sans identité propre. Commercialement, la page ne contient aucun levier de conversion au-delà des boutons d'inscription : ni preuve sociale, ni FAQ, ni capture de produit, ni argumentaire différencié.

La demande existe pourtant : les recherches françaises autour de l'arrêt du tabac, du sevrage alcoolique ou du suivi d'abstinence sont massives et soutenues par les dispositifs nationaux (Tabac Info Service, Drogues Info Service, Alcool Info Service). Avec un travail de contenu ciblé, le site pourrait capter une partie de cette audience organique à coût quasi nul.

> **VERDICT.** SEO technique : 5/20 · Contenu : 3/20 · Autorité : 2/20 · Conversion : 6/20. Le potentiel est réel, mais il suppose d'abord de corriger les fondations techniques, puis de construire un corpus éditorial autour de la thématique.

2. SEO technique

Tableau 1 — Bilan technique relevé le 16 septembre 2026

Contrôle	État	Constat
HTTPS + HSTS	**Conforme**	Certificat valide, en-tête strict-transport-security présent, servi par Vercel.
Balise <html lang>	**Non conforme**	Le site est intégralement en français mais déclaré `lang="en"`. Les moteurs et lecteurs d'écran interprètent la page comme anglophone : impact direct sur le classement pour les requêtes françaises.
Sitemap XML	**Absent**	`/sitemap.xml` renvoie une 404. Aucun plan de site n'est soumis aux moteurs.
robots.txt	**Partiel**	Présent et correct (zones privées exclues), mais sans directive `Sitemap:`.
URL canonique	**Absent**	Aucune balise `rel="canonical"` (le site répond avec et sans www, sans consolidation).
Meta description	**À reprendre**	« Un compagnon doux pour suivre votre abstinence et vos consommations » : ton vague, sans mot-clé ni appel à l'action ; identique sur la page /confidentialite (duplication interne).
Balise title	**À reprendre**	« Addict Helper — Suivez votre abstinence » : correct mais générique ; aucune requête à fort volume n'est visée (ex. « suivi d'abstinence », « arrêter de fumer application »).
Open Graph / Twitter	**Incomplet**	`twitter:card` vaut `summary_large_image` mais **aucune og:image n'est définie** : les partages sur X, Facebook, WhatsApp, LinkedIn s'affichent sans visuel, ce qui détruit le taux de clic des liens partagés. Il manque aussi `og:url`, `og:locale` et `og:site_name`.
Données structurées	**Absent**	Aucun JSON-LD : la fiche ne peut pas apparaître comme application logicielle (`SoftwareApplication`), organisation (`Organization`) ni FAQ dans les résultats enrichis.
Favicons / PWA	**Minime**	Un seul `favicon.ico` ; pas d'icônes PNG 180/192 px, pas de `theme-color`, pas de manifeste.
Performance	**Satisfaisant**	Page légère, hero CSS, préchargement des modules : bonnes bases (à confirmer par un test Lighthouse/PageSpeed avec l'ajout des futures images).

2.1 Corrections prioritaires (jours 1–7)

- Passer la balise `<html lang="fr">` sur l'ensemble des pages.
- Générer un `sitemap.xml` et le déclarer dans robots.txt.
- Ajouter les canonicals, une og:image dédiée (1200 × 630), `og:url`, `og:locale=fr_FR`.
- Implémenter le JSON-LD `SoftwareApplication` + `Organization` + `FAQPage`.
- Différencier title et meta description par page ; réécrire la description avec mots-clés et CTA.

3. Contenu et sémantique

3.1 Un contenu unique d'environ 300 mots

La page d'accueil contient environ 300 mots, tous génériques (« Temps réel », « Motivant », « Simple »). Aucune page du site ne cible une requête identifiable : ni « arrêter de fumer », ni « sevrage alcoolique », ni « suivi d'abstinence », ni « aide addiction proche ». Résultat : le domaine ne peut se positionner sur aucune intention de recherche.

3.2 Aucun corpus éditorial

Il n'existe ni blog, ni guides, ni FAQ, ni pages par addiction (tabac, alcool, cannabis, jeux…), ni annuaire CSAPA crawlable (la mention est faite mais sans page indexable). Sur une thématique où les concurrents institutionnels et applicatifs publient massivement, l'absence de contenu condamne le site à la confidentialité.

3.3 Ciblage recommandé

Tableau 2 — Exemples de requêtes à cible prioritaire (France)

Type de requête	Exemples	Page à créer
Transactionnelle — application	« application arrêter de fumer », « app suivi abstinence », « compter jours sans fumer »	Pages d'accueil optimisée + fiche produit
Informationnelle — tabac	« comment arrêter de fumer seul », « sevrage tabagique symptômes »	Guide + lien vers Tabac Info Service (39 89)
Informationnelle — alcool	« arrêter l'alcool seul », « combien de temps sevrage alcool »	Guide + lien Alcool Info Service
Informationnelle — entourage	« aider un proche alcoolique », « comment parler addiction à un ami »	Page dédiée aidants/proches
Locale / institutionnelle	« CSAPA + ville », « centre addiction près de chez moi »	Annuaire CSAPA indexable

> **ANGLE DIFFÉRENCIANT.** Plutôt que de concurrence frontalement les acteurs institutionnels, positionner Addict Helper comme l'outil de suivi privé qui les complète — et créer du contenu qui les cite : c'est bon pour l'utilisateur et cohérent avec la promesse du produit.

4. Autorité et netlinking

Le site est hébergé sur un sous-domaine personnel (`addict-helper.ronanbch.com`). Trois conséquences :

- **Marque inexistante dans l'URL** — difficile à mémoriser, à dicter et à associer à un service de santé ; le nom de domaine racine appartient à une personne, ce qui interdit toute stratégie de marque pérenne.
- **Autorité de domaine quasi nulle** — un sous-domaine isolé ne bénéficie d'aucun historique, d'aucun lien entrant, d'aucune notoriété.
- **Confiance réduite** — pour un produit manipulant des données potentiellement de santé, une adresse personnelle est un signal de fragilité (qui gère le service ? jusqu'à quand ?).

Recommandation. Enregistrer un nom de domaine dédié (par exemple addict-helper.fr), mettre en place des redirections 301 depuis l'ancien sous-domaine, et créer une fiche établissement / pages « À propos » et « Contact » identifiant clairement l'éditeur. Pour les futurs backlinks : viser les annuaires de santé, associations d'aidants, blogs de réduction des risques, et pages ressources des CSAPA.

5. Marketing et conversion

5.1 Levier principal : le référencement de la recherche francophone

La thématique bénéficie d'une demande structurelle : chaque mois, le dispositif national « Mois sans tabac » mobilise des centaines de milliers de personnes, et les lignes d'aide officielles traitent des volumes d'appels importants (Tabac Info Service revendique un accompagnement téléphonique gratuit et personnalisé ; Drogues Info Service et Alcool Info Service écoutent 7 j/7 jusqu'à 2 h du matin). Une présence organique sur ces sujets capte une audience chaude au bon moment.

5.2 Déficits de la page de vente

- Aucune preuve sociale (témoignages, chiffres) ni garantie crédible (voir l'audit UX associé).
- Aucune capture du produit : l'argumentaire est 100 % verbal.
- Aucune FAQ : les objections (anonymat, rôle des proches, rechute) restent sans réponse.
- Partage social cassé : sans og:image, chaque lien partagé par un utilisateur ou un proche s'affiche nu.
- Pas de capture d'e-mail pour les visiteurs non prêts à s'inscrire (newsletter de motivation, par exemple).

5.3 Leviers à activer

Tableau 3 — Actions marketing par impact et effort

Action	Impact	Effort
Corriger og:image + JSON-LD + lang fr (prérequis à tout partage)	Élevé	Faible
Montrer le produit (maquettes d'écran) et ajouter témoignages	Élevé	Moyen
Créer une FAQ (base SEO + conversion)	Moyen	Faible
Lancer 4–6 pages guides ciblées (tabac, alcool, aidants, CSAPA)	Élevé	Moyen
Nom de domaine dédié + pages À propos / Contact	Moyen	Faible
Newsletter / e-mail de motivation (rétention + retour)	Moyen	Moyen
Partenariats : annuaires santé, associations, forums d'aide mutuelle	Élevé	Élevé

6. Conformité et confiance

- **RGPD.** Le site traite potentiellement des données sensibles (addictions). La politique de confidentialité existe, mais il manque : mentions légales identifiant l'éditeur, éventuel bandeau de consentement si des mesures d'audience sont ajoutées (à prévoir dès la mise en place d'outils d'analytics), et durées de conservation explicites.
- **Données de santé.** Si le produit évolue vers un véritable suivi de santé partagé avec des soignants, anticiper les exigences renforcées (hébergement de données de santé, consentement explicite des proches aidants).
- **Responsabilité.** Ajouter une mention claire : l'outil accompagne mais ne se substitue pas à un professionnel de santé, et orienter vers les lignes nationales — démarche cohérente avec les dispositifs publics existants.

7. Plan d'action 30 / 60 / 90 jours

Tableau 4 — Feuille de route recommandée

Horizon	Actions
Jours 1–30	Corrections techniques (lang fr, sitemap, canonicals, og:image, JSON-LD, titles/descriptions par page) · nom de domaine dédié + redirections · maquette produit dans le hero · footer structuré avec ressources d'aide · FAQ · mentions légales.
Jours 31–60	Publication des 4–6 premières pages guides · annuaire CSAPA indexable · 3 premiers témoignages · inscription à la Search Console + suivi des requêtes · base newsletter.
Jours 61–90	Contenu éditorial régulier (2 articles/mois minimum) · premiers partenariats et backlinks · campagne Mois sans tabac (novembre) avec page dédiée · itérations SEO selon les données Search Console.

8. Indicateurs à suivre

Tableau 5 — KPIs recommandés

Catégorie	Indicateur	Outil
Visibilité	Impressions et positions moyennes sur les requêtes cibles	Google Search Console
Trafic	Sessions organiques françaises, pages guides vues	Analytics respectueux de la vie privée (ex. Plausible)
Conversion	Taux de clic vers /auth?mode=signup, taux d'inscription complétée	Analytics produit
Partage	Clics sur les liens partagés (avec og:image corrigée)	Réseaux sociaux / Search Console
Rétention	Taux de retour à J+7 / J+30 des inscrits	Analytics produit

Sources publiques vérifiées le 16 septembre 2026 : annuaire service-public.gouv.fr (fiches Tabac Info Service 39 89, Drogues Info Service 0 800 23 13 13, Alcool Info Service 0 980 980 930) ; sites officiels tabac-info-service.fr, drogues-info-service.fr, alcool-info-service.fr ; santé.gouv.fr (dispositif d'accompagnement à l'arrêt du tabac).